

Fecha Última Actualización: 20-05-2022 10:56:11

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Marisol Andrea Henríquez Henríquez **Rut** : 17.953.563-7 **N° Archivo** : 1607590
Edad : 30a 9m 21d **Fecha Nacto**: 29/07/1991 **Sexo** : Femenino
Dirección : Calle Hydra Block 2763 Dpto F312 Villa Sa **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 993122585

N° Epicrisis
304133

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Ingreso** : 19/02/2022 04:59 **Días Estadía**: 90
Unidad de Egreso : Medicina Básica (2do Piso) **Fecha Egreso** : 20/05/2022 15:00

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

ASMA; Obesidad;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Ecmo Adulto - 25/02/2022 00:00 - Emilio Antonio Flores Araya
Traqueostomía (Proc. Aut.) - 21/03/2022 15:30 - Manuel Francisco Manzor Veliz
Ecmo Adulto - 07/03/2022 12:00 - Enrique Andres Perez Bustos
Ecmo Adulto - 25/02/2022 00:00 - Emilio Antonio Flores Araya

Epidemiología

- Infec: Sepsis por cateter venoso - Germen: Estafilococo Aureus Meticilino Resistente (SAMR)
- Infec: Bacteremia - Germen: Estafilococo Aureus Meticilino Resistente (SAMR)
- Infec: Candidiasis Vulvovaginal - Germen:
- Infec: Colonización - Germen: K. Pneumoniae Kpc/Ndm
- Infec: Neumonía asociada a ventilación mecánica - Germen: Estafilococo Aureus Meticilino Resistente (SAMR)
- Infec: Neumonía asociada a ventilación mecánica - Germen: Klebsiella BLEE
- Infec: Neumonía asociada a ventilación mecánica - Germen: Klebsiella Aerogenes + Escherichia Coli Ms Y Samr
- Infec: Neumonía asociada a ventilación mecánica - Germen: Pseudomona Aureginosa

Resumen Clínico

FECHA DE INGRESO HSR: 19/02/2022
FECHA DE INGRESO UCI: 19/02/2022
FECHA DE INGRESO SALA: 04/05/2022

ANTECEDENTES

- Médicos: Asma mal controlada con antecedentes de hospitalización en UCI 2021 por crisis asmática y NAC requiriendo IOT/ARM/Traqueostomía; Obesidad; Lesión ósea en pómulo en plan de plastía (no realiza seguimiento)
- Quirúrgicos: Tumor facial (Fibroma) con tratamiento quirúrgico en 2017
- Medicamentos: Salbutamol, Bromuro de ipratropio
- Alergias: No
- Hábitos: tabaquismo activo, OH (-) Drogas (-)
- Inmunizaciones: Sin vacunas COVID-19

HISTORIA ACTUAL:

Paciente con antecedentes descritos, consulta por cuadro clínico de 48 hrs evolución caracterizado por disnea progresiva sin otros datos, ingresando a Servicio de Urgencia con insuficiencia respiratoria severa, con PCR COVID-19 (+). Se realiza AngioTAC de tórax que evidencia infiltrado periférico y parahiliar bilateral compatible con Neumonía por SARS CoV-2, descarta tromboembolismo pulmonar. Se inicia oxigenoterapia, escalando a cánula nasal de alto flujo (CNAF) rápidamente con mala respuesta por lo que se decide intubación para Ventilación Mecánica Invasiva (VMI) el 19/02/22. Se traslada a UCI para

Fecha Epicrisis : 20/05/2022 10:56

Página 1 de 4

continuar manejo.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

Insuficiencia respiratoria aguda parcial grave
Neumonía por SARS CoV-2 grave
Crisis asmática severa
VMI desde el 19/02
Antecedentes

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN

- Hemodinamia: al ingreso con requerimientos de drogas vasoactivas en contexto de sedoanalgesia, con dosis variable dependiendo de interurrencias infecciosas múltiples. Una vez extubada sin nuevo conflicto hemodinámico

- Respiratorio: al ingreso a UCI en VMI con mala respuesta, con PaFi de ingreso a unidad de 65. Se inicia protocolo de pronó el 20/02, sin respuesta, por lo que se decide conectar a dispositivo de oxigenación por membrana extracorpórea veno-venoso (ECMO-VV) el día 24/02. Evoluciona de forma favorable, por lo que se decide desconexión del ECMO el 07/03 (12 días en total) y progresiva tolerancia a la posición supina y a la suspensión del bloqueo neuromuscular (BNM). Dado ventilación mecánica prolongada se decide realizar traqueostomía quirúrgica el 21/03, evolucionando de forma favorable, logrando destete definitivo de ventilador mecánico el día 06/04. Una vez destetada evoluciona de forma adecuada en cuanto a decanulación, con buena evolución y decanulación de traqueostomía el 29/04, por lo que se traslada a sala básica con uso de oxígeno por naricera. En dicha unidad evoluciona de forma favorable, con lenta suspensión de requerimientos de oxígeno y con tendencia a la acidosis respiratoria, compatible con limitación crónica del flujo aéreo tipo asma remodelada. Al momento del alta hospitalaria sin requerimientos de oxígeno y con buena mecánica ventilatoria.

- Infeccioso: con múltiples interurrencias infecciosas durante hospitalización

- COVID-19: con COVID-19 grave al ingreso, completa corticoterapia 10 días en protocolo RECOVERY
- Bacteriemia por *Staphylococcus epidermidis* meticilino-resistente tratada con Vancomicina
- Neumonía asociada a la Ventilación Mecánica (NAVM) *Staphylococcus aureus* meticilino-resistente, tratada Vancomicina
- NAVM por *Pseudomona aeruginosa* MDR, tratada con Ciprofloxacino
- NAVM por *Klebsiella aerogenes* + *Escherichia coli* MS y *Staphylococcus aureus* meticilino-resistente, tratada con Ciprofloxacino + Vancomicina
- NAVM por *Klebsiella pneumoniae* BLEE KPC, tratada con Ceftazidima/Avibactam
- Infección del tracto sanguíneo asociada a catéter venoso central (ITS/CVC) por *Staphylococcus aureus* meticilino-resistente. Se retira dispositivo vascular con cultivo negativo. Tratada con Vancomicina por 5 días y luego con Linezolid dado sospecha de reacción adversa, con hemocultivos de control negativos y ecocardiograma transtorácico sin evidencias de endocarditis infecciosa y con cintigrama óseo negativo para foco de infección a distancia. Completa en total 14 días de tratamiento antibiótico desde hemocultivos negativos, con hemocultivos intratratamiento negativos.
- Candidiasis vulvovaginal: tratada de forma empírica con Fluconazol 150 mg por una vez.
- Colonización por *K. pneumoniae* KPC/NDM

- Cardiológico: durante estadía en UCI el 12/04 cursa con fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida paroxística que cede tras dosis única de Amiodarona. En sala básica se suspende Amiodarona dado frecuencia ventricular adecuada y descompensante controlado. Con CHA2DS2-VASc bajo, sin indicación de anticoagulación a largo plazo. En contexto de bacteriemia por *S. aureus* MR se realiza ecocardiograma transtorácico el cual informa aurícula izquierda no dilatada (36 mm), fracción de eyección 60% con motilidad segmentaria normal, sin evidencias de endocarditis infecciosas.

- Gastroenterológico: durante estadía hospitalaria evoluciona con alteración de pruebas hepáticas en patrón colestásico de forma intermitente y fluctuante en contexto de polifarmacia del paciente crítico. Dentro del estudio destaca bilirrubina normal, ecografía abdominal sin factor obstructivo, y múltiples fármacos que podrían ser causantes del cuadro con sospecha de hepatotoxicidad (DILI). Dado colestasia persistente tras suspensión de fármacos implicados se solicita estudio autoinmunitario con ANA (-), AMA (-), ASMA (-), sin hipergammaglobulinemia y con colangiografía magnética realizada el 19/05 (pendiente INFORME). Dado DILI con Ley de Hy (-) se decide seguimiento ambulatorio de pruebas hepáticas tras suspensión de antibióticos.

- Rehabilitación: durante VMI se mantuvo con nutrición enteral continua. Una vez decanulada de traqueostomía se progresa con rehabilitación fonoaudiológica con buena respuesta. En cuanto a lo motor, con miopatía importante en contexto de estadía

Fecha Última Actualización: 20-05-2022 10:56:11

Página 3 de 4

de larga data en UCI, una vez trasladada a sala básica logra control de marcha y bipedestación con apoyo. Al momento del alta permanece con miopatía de predominio proximal principalmente en extremidades superiores y con ingesta oral conservada sin restricción de consistencias.

- Otorrinolaringológico: durante el proceso de rehabilitación con traqueostomía cursa con mala tolerancia a válvula de fonación. Se solicita evaluación por especialidad quienes diagnosticaron otitis media con efusión en oído derecho, signos de reflujo faringolaríngeo y disfunción de articulación temporomandibular bilateral. Al alta con inhibidores de la bomba de protones por 6 semanas y control al alta con especialidad para audiometría e impedanciometría. Control ambulatorio con odontología temporomandibular.

- Nefrológico: función renal conservada durante toda estadía hospitalaria. Sin conflicto.

Dado buena evolución se decide alta hospitalaria con hospitalización domiciliaria para rehabilitación motora.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO:

Insuficiencia respiratoria grave recuperada

- Neumonía por SARS CoV-2 grave, resuelta

- Crisis asmática severa, resuelta

- VMI desde el 19/02 al 21/03 (32 días) + PP + BNM 2 ciclos

- ECMO VV 24/02 al 07/03 (12 días)

- TQT quirúrgica 21/03 al 29/04

- Infección del tracto sanguíneo por Staphylococcus aureus meticilino-resistente tratada, no complicada

- Bacteriemia por Staphylococcus epidermidis meticilino-resistente tratada

- Neumonía asociada a la Ventilación Mecánica por Staphylococcus aureus meticilino-resistente, tratada

Neumonía asociada a la Ventilación Mecánica por Pseudomona aeruginosa multidrogo-resistente, tratada

Neumonía asociada a la Ventilación Mecánica por Klebsiella aerogenes + Escherichia coli y Staphylococcus aureus meticilino-resistente, tratada

Neumonía asociada a la Ventilación Mecánica por Klebsiella pneumoniae BLEE KPC, tratada

Alteración de pruebas hepáticas en patrón colestásico persistente en estudio, sospecha de injuria hepática inducida por drogas (DILI)

Fibrilación auricular paroxística, sin anticoagulación

Candidiasis vulvovaginal tratada

Portación Klebsiella pneumoniae NDM/KPC

Miopatía del paciente crítico en rehabilitación

Disfagia severa del paciente crítico resuelta

Delirium hipoactivo multifactorial resuelto

Otitis media con efusión derecha

Antecedentes: asma de mal control

Diagnóstico de Egreso

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) - Grave, Por Covid-19, Resuelta

Lcfa Por Asma Remodelada -

Insuficiencia Respiratoria Crónica -

Miopatía De Paciente Crítico -

Disfunción Temporo-Mandibular -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

Buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable, sin requerimientos de oxígeno. Con miopatía en rehabilitación. En condiciones de alta hospitalaria con hospitalización domiciliaria con objetivo de rehabilitación motora.

Plan Post Alta

INDICACIONES

MEDIDAS GENERALES

Reposo relativo

Régimen común sin restricción de consistencias

Rehabilitación kinésica

Fecha Epicrisis : 20/05/2022 10:56

Página 3 de 4

Fecha Última Actualización: 20-05-2022 10:56:11

Página 4 de 4

Vacunación antineumocócica
Vacunación COVID-19
Vacunación antiinfluenza

MEDICAMENTOS:

Berodual ® (Bromuro de Ipratropio/Fenoterol), realizar 2 puff c/6 horas por aerocámara uso permanente
Budesonida inhalador, realizar 2 puff c/12 horas por aerocámara, uso permanente
Quetiapina 25 mg, tomar 1/2 comprimido c/24 horas vía oral, uso permanente
Omeprazol 20 mg, tomar 1 comprimido c/12 horas por 6 semanas vía oral, luego suspender

HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA: rehabilitación kinésica

CONTROLES

Control con Medicina Interna en CDT para control post-hospitalización, manejo de enfermedades crónicas y seguimiento de pruebas hepáticas. Se contactará telefónicamente para otorgar hora.

Control con Otorrinolaringología en CDT según disponibilidad de agenda. Se entrega formulario de interconsulta para acceder a prestación.

Control con Odontología (Trastornos Temporomandibulares) en CDT según disponibilidad de agenda. Se entrega formulario de interconsulta para acceder a prestación.

Sera contactada por teléfono para administración de vacunas por enfermera Rocío Roman

CONSULTAR EN EL SERVICIO DE URGENCIAS EN CASO DE: compromiso de conciencia, fiebre, dificultad respiratoria, dolor al pecho o en caso de estimarlo necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos : Quetiapina 25 Mg 1/2 Comprimido C/24 Horas Vía Oral
Omeprazol 20mg 1 Comprimido C/12 Horas Vía Oral
Budesonida 200mcg/Dosis 2 Puff C/12 Horas Por Aerocámara
Bromuro Ipratropio/Fenoterol Inhalador 10ml 2 Puff C/6 Horas Por Aerocámara

Controles

S/F - CDT - Otorrinolaringología -

S/F - CDT - Odontología -

S/F - CDT - Medicina Interna - SERA LLAMADA POR TELEFONO PARA AGENDAR HORA

INTERNO



Beatriz Matías Tapia Paschke
Becado/Residente



Esteban Andrés Araos Baeriswyl
Médico Tratante (Staff)